

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5092496-51.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: ROBERTO BLOISE

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

AGRAVO/MEDIDA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CÂNCER DE BEXIGA. LAUDO MÉDICO ATESTA A EXISTÊNCIA DA ENFERMIDADE E NECESSIDADE DE TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ARTIGO 196 E 198 DA CRFB/88 E JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DEFERDIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para CONCEDER A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA, na forma do art. 300 do CPC e conforme fundamentação acima, para determinar que os réus, conforme suas respectivas atribuições fixadas pelo SUS, forneçam, em no máximo 72 (setenta e duas) horas, a partir da intimação, a realização TRANSFERÊNCIA para TRATAMENTO CLÍNICO DE PACIENTE ONCOLÓGICO em HOSPITAL COM SUPORTE ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA capaz de realizar o tratamento, com cuidado integral, de que necessita a autora, em até 48 (quarenta e oito) horas. Na impossibilidade, seja a autora encaminhada para clínica ou hospital privado, conveniadas ao SUS, com o pagamento dos serviços prestados de acordo com a Tabela prevista no Convênio entre o Hospital/Clinica Privados e o SUS. O descumprimento da presente decisão, no prazo acima fixado, ensejará a aplicação de multa única no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertida em favor da parte autora, não afastada a adoção das demais medidas coercitivas aplicáveis à espécie. Sem custas, nem honorários, nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2024.

5092496-51.2024.4.02.5101

510015026268 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5092496-51.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: ROBERTO BLOISE

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência (agravo de instrumento) interposta pela parte Autora, em face de despacho, evento 3 dos autos originários, que indeferiu tratamento clínico especializado em oncologia à parte autora, que sofre de câncer na bexiga.

Eis o teor do despacho:

ROBERTO BLOISE propõe a presente demanda, pelo rito dos Juizados Especiais Federais, com pedido de antecipação de tutela e provimento final, por meio da qual a parte autora, portador de neoplasia maligna de bexiga, requer a condenação da União Federal, do Estado/RJ e do Município do Rio de Janeiro, em responsabilidade solidária, na obrigação de providenciarem a transferência do paciente para hospital com suporte especializado em oncologia, de acordo com as respectivas necessidades clínicas.

Passo a decidir.

Narra a parte autora, em apertada síntese, que está internado no Hospital Ronaldo Gazolla, desde 04/09/2024, com diagnóstico de neoplasia maligna de bexiga, em acompanhamento oncológico desde 2020.

De acordo com o relato médico que acompanha os autos, verifico que o autor apresenta sangue na urina de maneira persistente, com obstrução de repetição do cateter vesical, sendo necessária sua substituição em diversas ocasiões.

Após ter realizado ureterocistoscopia, foi evidenciada importante lesão vesical expansiva sem delimitação, estendendo-se por todo assoalho vesical, paredes laterais direita e esquerda, inclusive a colo vesical e parcialmente na próstata.

Após ressecção, laudo hispatológico identificou carcinoma urotelial invasivo de alto grau.

Nesse contexto, possui indicação para transferência para unidade com suporte oncológico.

Para o deferimento da tutela jurisdicional liminar, impõe-se a demonstração, de plano, de alta probabilidade quanto ao direito pretendido e, ainda, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do CPC), ou do abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, por parte do réu (art. 311, I, do CPC).

O caso concreto deve ser analisado à luz do disposto no art. 196 da Constituição Federal, que outorga verdadeiro direito subjetivo aos que necessitem dos serviços públicos de assistência à saúde, incumbindo ao Poder Público a tarefa de concretizá-lo (Nesse sentido: STF, RE-271286/RS, Relator Min. Celso de Mello, DJ 23/08/2000).

Do mesmo modo, o art. 198 do Texto Maior, ao dispor sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelece que este será financiado pela União, Estados-membros e Municípios, do que decorre a responsabilidade solidária dos referidos entes públicos.

Como forma de garantia e preservação da saúde, encontra-se incluído no campo de atuação do SUS a assistência terapêutica integral, nos termos do inciso, I, alínea d, do art. 6º da Lei nº 8.080/1990.

Cuida-se, portanto, de direito fundamental, consectário lógico do princípio da dignidade da pessoa humana e indissociável do direito à vida. Admite-se, assim, que o titular de tal direito possa postular, por meio da via judicial, prestação positiva do Estado que imprima ao comando constitucional eficácia plena.

Lado outro, não se pode olvidar de que o próprio art. 196 em comento estabelece a garantia do acesso universal e igualitário às ações e serviços direcionados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

Nesse diapasão, impende observar a “reserva do possível”, sob pena de ocasionar indesejáveis situações anti-isonômicas. Com efeito:

“o direito à saúde, positivado no art. 196 da Constituição, não significa acesso irrestrito a todo tipo de assistência médico-hospitalar, segundo a conveniência de cada paciente, cujas pretensões singulares ou atípicas, se atendidas sem juízo de ponderação e indiscriminadamente, podem comprometer a governança das redes públicas de saúde, vulnerando o ideal republicano da igualdade de todos perante a lei. Para não afetar o princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário só pode intervir nos critérios do SUS para afastar ilegalidades, sendo insuficientes a tal desiderato a mera exibição de laudos médicos, particulares ou oficiais, visto que na saúde pública os tratamentos sujeitam-se a múltiplos fatores, a saber: indisponibilidade momentânea do tratamento ou falta de leitos hospitalares; carência de recursos orçamentários; limitações terapêuticas e de ofertas de remédios; insuficiência de médicos, enfermeiros e auxiliares; a fase evolutiva de medicamentos até a sua aprovação definitiva pelos órgãos competentes” (TRF2, Sexta Turma Especializada, AG - Agravo de Instrumento - 233160, Des. Fed. Nizete Lobato Carmo, DJe 06/02/2014).

Nessa toada, insta dizer que, não obstante a urgência de cada caso concreto, não se pode perder de vista a possibilidade de haver outras tantas urgências ainda maiores aguardando o mesmo tipo de tratamento. Sob esse prisma, a eventual imposição do fornecimento aleatório e indiscriminado de certo tratamento tem o potencial de inviabilizar o próprio sistema de saúde pública.

Cabe, portanto, à Administração Pública a tarefa de organizar a fila de espera para a prestação de serviços de saúde. A intervenção do Poder Judiciário nessa seara só se legitima quando flagrante o desrespeito à ordem da fila de espera, ou em caso de risco iminente de morte, tudo em consonância com o princípio da igualdade que deve existir entre todos os pacientes.

É importante ressaltar que a fila de espera é formada e ordenada a partir de critérios médico-científicos, de modo que o Poder Judiciário não pode substituir, sem base em argumento técnico-pericial, a critério de prioridade médica para a realização de tratamentos efetuado pelos profissionais da própria área.

Com efeito, há uma fila de espera em razão do procedimento administrativo dos órgãos públicos que, para atender em igualdade de condições a todos, adota como critério de seleção a inscrição na central de regulação de leitos. Ou seja, trata-se de critério que, ante a

impossibilidade de tratamento imediato de todos, atende ao princípio constitucional da isonomia.

Assim, sem que esteja presente a demonstração de ilegitimidade da fila, decisão judicial determinando a transferência hospitalar imediata caracterizaria desrespeito ao acesso igualitário ao serviço de saúde, ante a situação comum em que se encontram os vários pacientes da fila, que podem estar em situação igual ou pior que a demandante.

Neste sentido é a jurisprudência do E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao se referir à fila de espera:

"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. INCA. CIRURGIA. FILA DE ESPERA. LEI Nº 12.732/12. NECESSIDADE DE DIAGNÓSTICO EM LAUDO PATOLÓGICO.

1. Com a vigência da Lei nº 12.732/12, verifica-se que o paciente com neoplasia maligna passou a ter o direito de receber, gratuitamente, no Sistema Único de Saúde, todos os tratamentos necessários. Ademais, a mesma lei dispõe em seu art. 2º que "o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único".

2. Todavia, em que pese o direito concedido ao agravado, é certo que não cabe ao Judiciário interferir nos critérios médicos utilizados para a organização da fila de atendimento. Precedentes TRF2.

3. Não cabe ao magistrado determinar os indivíduos que serão agraciados por uma vaga no instituto especializado ou em qualquer outro hospital da rede pública, uma vez que este não possui uma visão global acerca da situação dos demais pacientes. Deve-se respeitar a fila administrativamente formada com base em critérios médicos.

4. Embora o direito à saúde seja constitucionalmente garantido a todos, cabendo ao Estado, em sentido lato, promovê-lo mediante política sociais e econômicas (arts. 6º e 196 da CRFB/88), não se pode prejudicar outras pessoas em igual ou até pior situação, que têm prioridade na fila organizada administrativamente, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.

5. Cabe à Administração Pública, mediante exame com base em critérios técnicos, aferir a possibilidade de internação no INCA ou em qualquer outro hospital da rede pública, respeitando a fila administrativamente estabelecida.

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido."

(TRF2; Processo AG201302010107334; AG - 232519; Relator (a) Desembargador Federal José Antonio Lisboa Neiva; Órgão julgador: Sétima Turma Especializada; Data::17/12/2013). (Grifei)"

Impende registrar que não se desconsidera a situação pela qual passa a parte autora, em virtude do quadro de saúde apresentado. Contudo, não se vislumbra no caso razão suficiente para que se privilegie um paciente em detrimento dos outros integrantes da fila de espera do SUS, e que também aguardam por tratamentos médicos.

Decerto, em casos como o que ora se apresenta, o Magistrado deve ter uma visão macro do direito à saúde pleiteado, de maneira que, ao fazer justiça àquele que recorre ao Poder Judiciário, não pode cometer injustiça no que tange aos demais pacientes que aguardam a realização de consultas ou tratamentos, mediante inclusão na fila de espera.

Em outras palavras, ao menos em cognição sumária, não cabe ao Magistrado determinar quais indivíduos serão contemplados com o procedimento em unidade de saúde especializada ou em qualquer outro hospital da rede pública, por não possuir visão global acerca da situação dos demais pacientes, nem conhecimento sobre as prioridades, as enfermidades e a urgência de todos aqueles que aguardam a realização do mesmo tratamento.

Deste modo, entendo que o paciente já se encontra devidamente regulado e, portanto, assistido pela rede pública de saúde de acordo com as suas necessidades clínicas, inclusive mantido em unidade de terapia intensiva, sem evidência de infecção, como identificado pelo documento médico que instrui a exordial (1.2, página 9).

Ante o exposto, **INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA** vindicada, consoante manifestação supra.

Sem prejuízo, citem-se os réus para oferecimento de resposta, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 9º da Lei nº 9.099/95), devendo apresentar toda a documentação de que disponham para esclarecimento da causa, na forma do art. 11 da Lei nº 10.259/2001, bem como indicando, justificadamente, as provas que pretendem produzir, ou havendo possibilidade de conciliação, esta deve ser clara, detalhando todos os seus termos.

Deixo de designar audiência de conciliação, instrução e julgamento, pois a não realização não importa em prejuízo para as partes.

Alega a parte autora que se encontra internada no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, desde 04/09/2024, em razão de Neoplasia de Bexiga (CID 10 C67.8) desde 2020, com quadro de hematúria persistente e apresentando obstrução de repetição do cateter vesical três vias mesmo com irrigação continuam sendo necessária troca de cateter vesical em múltiplas ocasiões realizado pela equipe de urologia. Segundo laudo médico, o autor realizado em 04/10/2024 pela equipe da urologia do Hospital da Piedade uretrocistoscopia evidenciando importante lesão vesical expansiva em delimitação, estendendo-se por todo assoalho vesical, paredes laterais direita e esquerda, lesão estende-se inclusive a colo vesical e parcialmente à loja prostática, coágulo disperso na bexiga, realizando ressecção de fragmento de lesão para análise histopatológico e hemostasia local, tendo evidenciado carcinoma urotelial invasivo de alto grau, invadindo a lâmina própria, sem evidencia de invasão vascular ou linfática e com achados de necrose tumoral.

Tutela deferida em decisão desta relatora no evento 18.

Sem contrarrazões.

Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, a preservação da saúde é dever genérico solidário de todas as entidades federativas (art. 23, II e 196, CF/88). No entanto, as atribuições públicas específicas no campo da saúde, são descentralizadas, sendo a responsabilidade limitada à própria esfera de atribuições definidas em lei, conforme dispõem os art. 197 e 200 CF/88.

Nesse particular, descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços de saúde são diretrizes básicas e princípios constitucionais do Sistema Único de Saúde – SUS, “sic”:

“Art. 198 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo.” (grifo nosso)”

Regulamentando essa disposição constitucional e com ênfase especial à descentralização dos serviços, preceito inserido no art. 198, I CF/88, foram editadas as Leis nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e 8.142/90 (financiamento do SUS), além de inúmeras outras normas infraconstitucionais.

Nesse particular, é clara a Lei 8.080/90 quando determina a descentralização de medidas com ênfase para os municípios, conforme:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;(...)

A ênfase na municipalização passa então a ser também princípio do SUS, inserido no inciso IX, artigo 7º, da Lei 8.080/90. Cabe assim precipuamente aos Municípios a responsabilidade pela execução e pela prestação direta dos serviços de saúde (art. 18, incisos I, IV e V, da Lei n.º 8.080/90). Isso se compatibiliza com o sistema com o estabelecido também pela Constituição no artigo 30, VII: *“Compete aos Municípios (...) prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população.*

Destarte, fica evidente que as responsabilidades quanto à execução das ações finalísticas de prestação de serviços de saúde, dividem-se entre a União, os Estados e os Municípios, cada um dentro de suas respectivas esferas de atribuição, devendo-se ressaltar aqui, que à União compete basicamente a formulação de políticas nacionais, financiamento do Sistema, com o repasse de verbas próprias a Estados e Municípios, sendo que a estes últimos ficaria a principal atribuição de prestar o atendimento ao cidadão, especialmente no campo do fornecimento de medicamentos.

Vejam os agora questões específicas que se apresentam regularmente nesta Justiça Federal.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SAÚDE

As atribuições relativas à assistência farmacêutica no campo da saúde pública, englobam as *atividades de seleção, programação, aquisição, armazenamento e distribuição, controle da qualidade e utilização - compreendidas a prescrição e a dispensação - de medicamentos* (artigos 16, X; 17, VIII; e 18, V, da Lei n. 8.080/1990 e item 3.3 da Portaria MS n. 3.916, de 30 de outubro de 1998 - Política Nacional de Medicamentos). O Decreto nº 7.508/11 recentemente deu nova regulamentação à Lei 8.080/80, não alterando a linha da descentralização.

Em toda hierarquização e descentralização quanto ao fornecimento direto de medicamentos e demais insumos respectivos, fica claro que: (i) cabem ao gestor municipal as responsabilidades para definição dos medicamentos essenciais e para o seu abastecimento. Ou seja, os medicamentos fornecidos pelo município são aqueles considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de saúde da população; (ii) compete aos Estados federados a dispensação de medicamentos de ordem excepcional, ou seja, medicamentos utilizados em doenças raras, geralmente de custo elevado, cuja compra e disponibilização atende a casos específicos; (iii) por fim, quanto à União Federal, é conferida pela Política Nacional de Medicamentos a responsabilidade em adquirir e distribuir produtos em situações especiais considerando três pressupostos básicos, de ordem epidemiológica, a saber: a) doenças que configuram problemas de saúde pública, que atingem ou põem em risco a coletividade, e cuja estratégia de controle concentra-se no tratamento de seus portadores; b) doenças consideradas de caráter individual que, a despeito de atingir número reduzido de pessoas, requerem tratamento longo ou até permanente, com o uso de medicamentos de custos elevados; c) doenças cujo tratamento envolve o uso de medicamentos não disponíveis no mercado.

Portanto, a conclusão a que se chega é que a competência da União no fornecimento de medicamentos, conforme farta regulamentação, se refere aos: a) medicamentos de interesse em saúde pública: aqueles utilizados no controle de doenças que, em determinada comunidade, têm magnitude, transcendência ou vulnerabilidade relevante e cuja estratégia básica de combate é o tratamento dos doentes; e b) medicamentos de uso contínuo: são aqueles empregados no tratamento de doenças crônicas e ou degenerativas, utilizados continuamente, sendo que em ambos os casos, só serão fornecidos pela União aqueles que se encaixarem no perfil estratégico concernente à definição de sua esfera de responsabilidade.

Com base nessa divisão de responsabilidades, delimita-se a competência da Justiça Federal e conseqüentemente dos Juizados Especiais Federais para apreciar as ações que objetivam o fornecimento de medicamentos, atendo-se somente àquelas em que a dispensação de medicamentos caiba à União Federal.

Na mesma linha da argumentação acima, segue parte da jurisprudência do STJ e também a jurisprudência pacífica do TRF da 2ª Região, conforme, com grifos nossos:

“SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. EXECUÇÃO DIRETA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL. I - A Primeira Turma deste Superior Tribunal de Justiça vem decidindo pela ilegitimidade da União para figurar em ação para fornecimento gratuito de medicamentos. II - A competência da União está adstrita à gestão federal do SUS, repassando os recursos financeiros, cabendo então aos Municípios e, supletivamente, aos Estados, a aquisição e a adequada dispensação de medicamentos. Precedente: (AgRg no REsp nº 888.975/RS, Relator p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 22.10.2007). III - Agravo regimental provido. (STJ - AgRg no Ag 879.975/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, Rel. p/ Acórdão Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, Dje 14/04/2008)

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A sentença, também condicionada a reexame necessário, ratificando a decisão antecipatória, condenou somente a União a fornecer ao autor, portador de esquizofrenia psicótica, os medicamentos Losartana Potássica 100mg/dia; Pimozida 04 mg/dia; Flurazepan 30 mg/dia, e Dicloridrato de Manidipin, disponibilizando quantidade suficiente para o tratamento no período de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com a necessidade diária prescrita nos laudos médicos..., nas quantidades mensais especificadas com base nos receituários..., devendo o Autor apresentar, a cada 06 (seis) meses, receituário atualizado, comprovando a necessidade de uso continuado dos referidos medicamentos. 2. A União Federal, em regra, no âmbito do SUS, não tem atribuição de distribuir diretamente medicamentos, do que decorre a sua ilegitimidade passiva para responder ações movidas para obtê-los. Inteligência da Lei nº 8.080/90. Precedentes da Turma. 3. A remessa dos autos à Justiça Estadual, melhor ajustada à sistemática do SUS, tem o efeito prático de aproximar os pacientes

necessitados de assistência médico-farmacêutica dos organismos locais responsáveis, assim otimizando a efetividade das prestações demandadas. 4. Na hipótese, a parte autora, portadora de esquizofrenia psicótica, necessita de remédios não integrantes da lista de medicamentos excepcionalmente fornecidos pela União Federal, e dos autos não consta laudo médico categórico afirmativo da essencialidade dos medicamentos em causa, destacando-os como únicos e insubstituíveis para restabelecer a saúde do paciente, e situando-o, nessa medida, em quadro excepcional para justificar tratamento diferenciado, de sorte que se impõe a remessa do feito ao Estado. 5. Apelação da União Federal e Remessa Necessária providas. Apelação da parte autora e agravo retido prejudicados."

(TRF2, APELRE 200951010132455, Desembargadora Federal NIZETE LOBATO CARMO, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R 22/01/2013.)

"AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. EXCLUSÃO DA UNIÃO DO PÓLO PASSIVO. 1. Agravos internos contra a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento e determinou a exclusão da União do pólo passivo da demanda na qual se pede a entrega de medicamentos, com a remessa dos autos ao Juízo estadual competente. 2. A asseveração de solidariedade apenas significa que os entes federativos dos três níveis têm o dever de compor o sistema de saúde pública, na forma delineada pela Constituição Federal e especificada pela legislação infraconstitucional. Assim, ela é insuficiente para fazer com que se possa litigar ou não contra a União Federal, em casos nos quais não existe, na distribuição interna das competências, dever da União de comprar ou fornecer o remédio específico. 3. Agravos internos não providos."
(TRF2, AG 201202010183666, Desembargador Federal GUILHERME COUTO, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R 17/12/2012.)

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL. REMESSA À JUSTIÇA DO ESTADO.

Em regra, não é pertinente a inserção da UNIÃO FEDERAL no pólo passivo de pleito em que se objetiva obter remédios. A atuação da União Federal, no âmbito do problema relativo a medicamentos, não é a de comprá-los e de distribuí-los, diretamente. O Sistema Único de Saúde objetiva coordenar os recursos e práticas ligadas à saúde pública, de modo a dividir atribuições e obter eficiência. Não cabe à União a compra e a entrega direta de medicamentos, salvo os casos especiais previstos na divisão de atribuições. Assim, exclui-se da lide a União Federal e, com fulcro no artigo 113 do CPC, pronuncia-se a nulidade da sentença, determinada a remessa dos autos à Justiça do Estado, para que lá tudo seja apreciado. Remessa (conhecida de ofício) e apelação da UNIÃO FEDERAL providas. Prejudicado o apelo do Estado do Rio de Janeiro.(TRF2 - AG 201202010107937, Rel. p/acórdão GUILHERME COUTO, E-DJF2R - Data::26/09/2012.)

"PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Conquanto a apreciação do agravo retido interposto pela União não tenha sido requerida em sua apelação (art. 523, § 1º, do CPC), o recurso poderia ser conhecido por força da remessa necessária. Todavia, não o será porquanto se insurge contra o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela e porque a ilegitimidade passiva suscitada é reiterada nas razões de apelação. 2. A aquisição e distribuição dos medicamentos para combater a doença que acomete a autora (glaucoma) inserem-se entre as atribuições do Estado e do Município (art. 9º, §1º, inciso II, da Portaria nº 288/ SAS, de 19 de maio de 2008). Desprezar a repartição de atribuições, prevista na Lei nº 8.080/90 (artigos 16 a 19) e demais normas que regulamentam o funcionamento do SUS, torna o sistema ineficiente e dispendioso, notadamente em vista de condenações solidárias dos entes ao fornecimento dos mais variados medicamentos. A União não tem a incumbência de adquiri-los e distribuí-los, pois os medicamentos pleiteados não estão listados na Portaria nº 2.981/2009. Reconhecida a ilegitimidade da União e, portanto, a incompetência da Justiça Federal, deve ser declarada a nulidade da sentença e encaminhado o processo à Justiça Estadual (art. 113, § 2º, do CPC). 3. Agravo retido da União não conhecido e remessa e apelação da União providas. Prejudicados os recursos dos demais réus." (grifou-se e destacou-se).(TRF2, AC 200851010252432, Desembargador Federal LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO, SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R 08/03/2013)

Portanto, tratamento oncológico está expressamente ressalvado enquanto atendimento urgente que deve ser feito com prioridade.

Conforme Parecer do NATJUS no evento 6, consta que "em consulta à plataforma eletrônica do SER - Serviço Estadual de Regulação, foi identificada para o Autor Solicitação de Internação inserida em 22/10/2024 pelo Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, com situação "Cancelada", não constando entretanto o motivo deste cancelamento (ANEXO II)".

Diante desta informação, houve intimação do Estado do Rio de Janeiro, por esta relatora, por meio de despacho do evento 8, para que justificasse o motivo do cancelamento, sendo certo que, ao menos, visto que cancelou, deveria ter apresentado outra via de atendimento, em razão da gravidade em que se encontra o autor.

Por sua vez, o Estado do Rio de Janeiro permaneceu silente, sendo certo que o autor fora retirado da fila de atendimento oncológico, sem qualquer nova inclusão ou previsão de data, sendo completamente excluído seu entendimento.

Analizada estas questões, verifico que, mediante análise meramente perfunctória, encontro na exposição da lide a presença dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada indeferida pelo Juízo *a quo*, visto que o autor fora excluído da fila de atendimento do SUS, sem qualquer justificativa ou nova previsão de tratamento, não podendo esperar ad eternum a providência do Estado do Rio de Janeiro para efetuar sua nova inclusão no sistema.

Constato que há risco de dano irreparável em prejuízo da recorrente, pois restou incontroverso o estado grave de saúde que se encontra o autor, bem como a falha da prestação do servido do Estado do Rio de Janeiro e sua inércia em fornecer atendimento ao autor.

Eis os documentos supracitados que comprovam a urgência e risco de vida da parte autora:

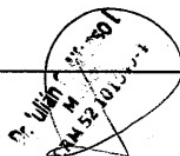
		HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	
		AV PASTOR MARTIN LUTHER KING, 10976 - ACARI - RIO DE JANEIRO - RJ - 21531010	
Receituário			
Paciente: ROBERTO BLOISE		Idade: 72	
Data: 01/11/2024 15:53:21	Sexo: Masculino	CPF: 33299188704	BAE: 3171374
Linha de Cuidado: CLINICA CIRURGICA			

LAUDO MÉDICO

Paciente Roberto Bloise de 72 anos de idade internado nesta unidade desde 04/09/2024 com diagnóstico de neoplasia de bexiga desde 2020, com quadro de hematúria persistente e apresentando obstrução de repetição do cateter vesical três vias mesmo com irrigação contínua, sendo necessário troca de cateter vesical em múltiplas ocasiões realizado pela equipe de urologia. Realizado em 04/10/2024 pela equipe da urologia do Hospital da Piedade uretroscopia evidenciando importante lesão vesical expansiva sem delimitação, estendendo-se por todo assoalho vesical, paredes laterais direita e esquerda, lesão estende-se inclusive a colo vesical e parcialmente à loja prostática. Coágulo disperso na bexiga. Realizado ressecção de fragmento de lesão para análise histopatológica e hemostasia local. Laudo de histopatológico: Carcinoma urotelial invasivo de alto grau, invadindo a lamina própria, sem evidência de invasão vascular ou linfática e com achados de necrose tumoral.

Paciente no momento mantido em unidade de terapia intensiva, necessitando de terapia renal substitutiva, e necessidade de irrigação vesical contínua por persistência de hematúria. Sem tratamento antibiótico vigente nem evidência de infecção, aguardando transferência via SER para hospital com serviço de oncologia.

CID C678



Dr. JULIAN CAMILO ALFONSO DIAZ

CRM/RJ: 1015494

Portanto, vislumbro preenchidos os pressupostos autorizadores da antecipação de tutela previstos no art. 300 do CPC.

Ante o exposto, voto por **CONHECER E DAR PROVIMENTO** ao recurso, para **CONCEDER A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA**, na forma do art. 300 do CPC e conforme fundamentação acima, para determinar que os réus, conforme suas respectivas atribuições fixadas pelo SUS, forneçam, em no máximo 72 (setenta e duas) horas, a partir da intimação, a realização TRANSFERÊNCIA para TRATAMENTO CLÍNICO DE PACIENTE ONCOLÓGICO em HOSPITAL COM SUPORTE ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA capaz de realizar o tratamento, com cuidado integral, de que necessita a autora, em até 48 (quarenta e oito) horas. Na impossibilidade, seja a autora encaminhada para clínica ou hospital privado, **conveniadas ao SUS**, com o pagamento dos serviços prestados de acordo com a Tabela

prevista no Convênio entre o Hospital/Clinica Privados e o SUS. O descumprimento da presente decisão, no prazo acima fixado, ensejará a aplicação de multa única no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertida em favor da parte autora, não afastada a adoção das demais medidas coercitivas aplicáveis à espécie. Sem custas, nem honorários, nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto.